

Fecha Última Actualización: 20-05-2022 2:50:11

Página 1 de 5

Información Paciente

Nombre : Juan Luis Mino Gutierrez
Edad : 71a 6m 2d
Dirección : Patacones 1105

Rut : 5.958.870-2
Fecha Nacto: 18/11/1950
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1725450
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 9510 0916

N° Epicrisis
296932

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim

Fecha Ingreso : 20/02/2022 22:30

Días Estadía : 89

Unidad de Egreso : Utim

Fecha Egreso : 20/05/2022 02:50

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea

Comorbilidades

Diabetes Mellitus 2;

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Juan Luis Miño Gutiérrez
5958870-2
71 años
Ingreso CASR
20/02/22
Días de Hospitalización
84
FI CASR: 20/02/22
FI UTIM: 21/02/22
FI UPC: 23/02/22
FE UTIM 15/13/22
FE CASR:

Nombre: Juan Luis Miño Gutiérrez
RUT: 5958870-2
Edad: 71 años
FI CASR: 20/02/22
FI UTIM: 21/02/22
Contacto: 9 9510 0916 (ex-pareja)

Antecedentes:

- Mórbidos: DM2 NIR, HTA, Parálisis facial periférica antigua
- Quirúrgicos: Colectomía
- Fármacos: Losartán, Metformina, AAS
- Alergias: (-)
- Hábitos: TBQ (+), suspendido hace 30 años, OH (-), Drogas (-)
- Hospitalizaciones recientes: Neuropatía de VIII par derecho en 2017, Paresia de III par izquierdo 2019, impresiona por diabetes
- Social: Diseñador gráfico. Vive en casa con señora e hijos. IAIVD
- Inmunizaciones: Sin vacunas COVID-19 por decisión personal

Fecha Epicrisis : 20/05/2022 02:50

Página 1 de 5

Motivo de Consulta: Disnea

Historia de ingreso:

Paciente con antecedentes descritos, con historia de síntomas respiratorios altos desde el 05/02, consulta en APS, donde se solicita Antígeno de COVID 19, positivo el 07/02, por lo que inicia aislamiento en domicilio evolucionando con disnea progresiva hasta reposo, por lo que decide consultar.

Ingresa al SU CASR hipertenso, normocárdico, afebril, saturando 80% ambiental, por lo que se apoya con O2. Al EF vigil, cooperador y orientado, MP (+) levemente disminuido en ambos campos pulmonares. Con diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda por neumonía por COVID-19, se solicitan exámenes de laboratorio y AngioTC de Tórax:

Glic 285, ELP 141/5.01/116, Crea 3.1, BUN 89.9, Hcto 31.8, Hg 10.8, GB 7200, PQT 238000, PCR 78.7, TP 80%, INR 1.15, TTPK 29, BT 0.55, FA 113, GGT 65, GOT 62, GPT 62, Alb 3.1, GSA: pH 7.223, Co2 32.5, HCO3 13.1, BE -13.3, Lactato 27.1

AngioTC de Tórax (21/02): Examen negativo para tromboembolismo pulmonar agudo.

Neumopatía multifocal bilateral en evolución, con patrón altamente sugerente de infección por Covid-19.

Nódulo cortical renal derecho, no caracterizable en este estudio. Cuando la condición clínica del paciente lo permita se sugiere realizar estudio dirigido.

Se diagnostica hiperglicemia con criterios de cetoacidosis diabética e insuficiencia renal aguda de probable etiología prerenal, por lo que se inicia volemicización, BIC de insulina y control de exámenes cada 2 horas.

Se traslada a UTIM, se maneja con BIC de insulina y volemicización controlada por falla renal. Se inicia manejo con dexametasona, se apoya con CNAF por persistir desaturando con uso de venturi, PaFi 120. Al conectar a CNAF persiste con saturaciones límite, pese a parámetros en ascenso, sin apremio respiratorio o uso de musculatura accesoria. Evoluciona desorientado, inatento, y durante la madrugada del 22/02 presenta deterioro de la mecánica ventilatoria y alza de requerimientos de FIO2 por CNAF. Se intuba y conecta a VMI con parámetros protectores. PaFi de control 222. Requiere inicio de vasoactivos a dosis bajas en relación a uso de sedación. Evoluciona afebril, PCR 80 sin sospecha de sobreinfección bacteriana. Sin ATB. Persiste metabólicamente inestable con necesidad IC fluctante actualmente 7 cc/h por BIC y sin criterios de resolución de CAD.

Disfunción renal progresa hasta Crea 3.1 BUN 89.9, que disminuye con volemicización, con recuperación de diuresis. Se inicio trombopprofilaxis con HNF por falla renal.

Se solicita traslado a UPC.

Diagnósticos de ingreso:

Insuficiencia respiratoria aguda:

Neumonía por COVID-19 (FIS 05/02), día +16

Test de Antígeno COVID (+) 07/02

Sin vacunas COVID-19

Cetoacidosis Diabética en resolución

AKI KDIGO III obs prerenal

Sin criterios de urgencia dialítica

AKI sobre ERC

Delirium Hipoactivo

Antecedentes: DM2 NIR, HTA, Parálisis facial periférica antigua

Diagnósticos intrahospitalarios:

1.-Anemia severa sin hemorragia exteriorizada - hematoma pared abdominal 2° anticoagulación.

2.-Paciente neurológico y crítico crónico

oVMI prolongada (SDRA por COVID19) - salida TQT PCT 11/3.

oAVE isquémico frontal derecho - Obs cardioembólico

oMiopatía severa del paciente crítico+ secuelade AVE (paresia FBC I° + disfasia)

oDisfagia severa con aspiración silente - indicación de GTT

oUPP GI en talones, sacra, occipital

3.-Edema importante laringeo - sospecha reflujo faringo-laríngeo severo.

Fecha Epicrisis : 20/05/2022 02:50

Página 2 de 5

Fecha Última Actualización: 20-05-2022 2:50:11

Página 3 de 5

- 4.-Úlcera corneal de OI° + queratitis por exposición bilateral
- 5.-Portación E. faecium VAN B

Recuperados

- 6.-NAC COVID (FIS 05/02- PCR +21/02)
- 7.-Shock Mixto Séptico/Hipovolémico
- 8.-NAVM por S. Marcensens + Kp BLEE
- 9.-CAD resuelta
- 10.-Sangrado periostomía de TQT asociado a anticoagulación
- 11.-AKI KDIGO III sobre ERC recuperada (TRR desde 23/02-14/03)
- 12.-ITU por K. pneumoniae BLEE tratada
- 13.-Diarrea por C. difficile tratada
- 14.-FA con RVR resuelta
- 15.-Bacteriemia Serratia marcescens MR - foco urinario (HC 1y2 + UC 15/4) tratada 14 d Imipenem
- .-Antecedentes: DM2NIR, HTA Cr, Parálisis facial periférica

Evolución durante hospitalización en UPC-UTIM

-Hemodinamia: En UPC evoluciona con requerimientos intermitentes de DVA, usualmente a dosis bajas, asociado generalmente intradialisis. Caída progresiva de hematocrito, sin compromiso hemodinámico, TR negativo para melena. Durante el día 14/03 evoluciona con sangrado autolimitado y escaso de sitio de inserción de accesos vasculares. Se indica Tx de 1 UGR intradialisis. Sin DVA, buena perfusión, normocárdico. FA con adecuada respuesta ventricular. Mantiene anticoagulación dado evento tromboembólico durante estadía. Durante UTIM presenta crisis HTA 2° a hipervolemia por reanimación vigorosa y aportes parenterales, en manejo con BIC de Labetalol logrando PAM 110 y furosemida, logrando BH -500 a -1000, sin deterioro ventilatorio.

Presentó anemización el 22/3 hasta Hb 5.8g%, se asume por hematoma de pared abdomen-lumbar izquierda 2° a anticoagulación ya suspendida, angioTC AP sin hematoma profundo (describe pequeño hematoma femoral por CVC, instalado posterior a anemia), EDA limpia 21/03, mantiene Hb estable. El 05/05, presenta caída de un punto de Hb, de 8,2 a 7,2. Evoluciona, con caída progresiva de la hemoglobina, sin requerir nueva transfusión. Posteriormente, debido al mal pronóstico neurológico, deterioro progresivo de la función renal, y mal manejo de VEC, se conversa con familiares y se decide adecuar medidas terapéuticas. En este sentido se mantuvo sin . sin tromboprolifaxis, monitorizado con LAM, CUP para BH estricto.

-Cardio: AVE cardioembólico en contexto de FA RVR paroxística, omitiéndose estudio Holter y eco de vasos carotídeos. Indicación de anticoagulación y Bbloqueo, que fueron suspendidos por cuadro hemorrágico.

-Respiratorio: VMI prolongada por múltiples hits infecciosos y estado NLG, salida a TQT percutánea (11/03).

Lenta rehabilitación y mal manejo de secreciones, abundantes al SSG, el 04/4 evaluado por ORL con NFB evidencian edema de VAS sugerente de reflujo faringo-laríngeo, aspiración silente y pérdida de sensibilidad glótica.

Contraindicada oclusión, VF terapéutica, sin alteraciones anatómicas (visualización parcial) que contraindique decanulación futura, se dejó IBP 8 semanas y control con NFB.

Paciente presenta deterioro progresivo de función pulmonar con aumento de requerimientos de oxígeno hasta VMNI con bipap 12/7. El 18/05/22 se conversa con familiares sobre manejo y pronóstico, por lo que se decide adecuar medidas terapéuticas, y se desescala soporte ventilatorio con oxígeno suplementario por TQT. Se mantuvo con KNT motora y respiratoria.

-Infeccioso: Múltiples hits, descritos en diagnósticos. A destacar NAVM por S. Marcensens + Kp BLEE e ITU por K. pneumoniae BLEE., bacteriemia por Serratia, foco urinario dado crecimiento en UC, sin complicaciones al TC. Completó 14 días de Imipenem. posteriormente, se trata por 7 días ITU CUP sin microbiologías aislada. El 18/05 resulta CAET (+) ACBA MR y Serratia, se inicia tratamiento con colistin e imipenem.

-Neurológico: :En UPC Al suspenderse la sedación se objetivaron movimientos estereotipados de EESS y cuello, se solicitó TAC de cerebro que objetivo ACV isquémico frontal derecho de probable etiología ateroembólica, por lo que se inicia Anticoagulación, sin embargo, luego se suspende por anemización secundaria a hematoma. . Estudio de FRCV con LDL en 60. Actualmente, se mantiene sin crisis epiléptica, sin uso de fármacos antiepilépticos, ni profilaxis secundaria.

-Nutricional/metabólico: al ingreso cursó con Cetoacidosis diabética la cual se resolvió en UPC. Presento desnutrición calórica

Fecha Epicrisis : 20/05/2022 02:50

Página 3 de 5

Fecha Última Actualización: 20-05-2022 2:50:11

Página 4 de 5

proteica, previamente seguimiento por ANI, el 21/4 pierde vía enteral dado GTT frustra e imposibilidad de reinstalar SNG, se decide inicio de NPE, en miras de metas, pre-alb 25. El 02/05 se instala SNG bajo endoscopia, sin incidentes. Paciente con trastorno de deglución severo y mal manejo de secreciones, se decide realizar gastrostomía quirúrgica (GTT) el 06/05. Evoluciona con dolor moderado en sitio de herida operatoria, asociado a descenso de Hb. Se realiza TAC AP el 13/05, que no muestra sangrado ni signos de colecciones. Posteriormente, paciente mantiene íleo con altos débitos por GTT (mayor 400). Se maneja con prokinéticos con mala respuesta. El 18/05, en relación a ajuste de medidas terapéuticas, se decide suspender nutricionalmente parenteral. Se mantuvo con hidratación con dextrosa endovenoso.

-Renal/Medio interno: lábil, sin creatinina basal, evoluciona con AKI oligúrica en contexto de sepsis con requerimientos de TRR (23/02-14/03), posteriormente recupera función renal y se retira acceso. De entonces algunas fluctuaciones en contexto de obstrucción del CUP y otras ante hipovolemia. Posteriormente, destaca mal manejo de volumen y aumento progresivo de creatinina por lo que se decide suspender diuréticos. Evoluciona con disociación bun/crea, destaca nitrógeno ureico 70-80, sin evidencia de sangrado. En cuanto alteraciones hidroelectrolíticas, destaca la presencia de hipokalemias e hiponatremia recurrente.

-Oftalmología: queratitis por exposición bilateral + úlcera corneal de OI°, en manejo con lágrimas, colirio/ungüento CAF y moxifloxacino. Seguimiento por OFT, compresión ocular nocturna, instalan lente de contacto en OI y se ajustan ungüentos, quedando con lágrimas sin excipientes, CAF gotas y seguimiento.

-Tromboprofilaxis: Sin tromboprofilaxis por antecedente de hematoma con caída de Hb.
Evolución en UTIM

HDN: El 09/05 presenta Hb 6.7 por lo que se indica 1GR, hb del 17 en 6.8, ayer en 10, hoy en 6.3 sin exteriorización de sangrado. Se decide conducta expectante. Actualmente, hipertenso se mantiene con VDO, normocárdico, con VEC aumentado. Plan: Se decide mantener VDO, MNI.

-Respiratorio: VMI prolongada por múltiples hits infecciosos y estado NLG, salida a TQT percutánea (11/03). Lenta rehabilitación y mal manejo de secreciones, abundantes al SSG, el 04/4 evaluado por ORL con NFB evidencian edema de VAS sugerente de reflujo faringolaríngea, aspiración silente y pérdida de sensibilidad glótica.

Destaca aumento progresivo de requerimientos de O₂, durante la semana pasada, se mantuvo con VMNI 12/7 con 2 lts sin aumento de mecánica ventilatoria. Se decide adecuar medidas terapéuticas, por lo que se decide suspender VMNI y pasar soporte con O₂ por TQT. Hoy se cambia bic de morfina a metadona horario por clearance renal disminuido. Actualmente, sin aumento de mecánica ventilatoria. Plan: Mantener soporte de O₂ suplementario y evaluar respuesta a opiodes según disnea.

-Infeccioso: Múltiples hits, descritos en diagnósticos.

Última bacteriemia por Serratia, foco urinario dado crecimiento en UC, sin complicaciones al TC. Completó 14 días de Imipenem. En contexto de aumento de PPII al alza con orinas piuricas e SO que resulta inflamatoria. Completo 7 días de tratamiento con imipenem. Al control de exámenes destaca PPII estacionario 130, en CAET se rescata NAAS ACBA MR y Serratia M. Se conversa con equipo de infectología y se decide iniciar carga de colistina, luego dosis a mantención asociado a imipenem. Plan: Seguimiento con PPII.

-Nutricional/metabólico: desnutrición CP, previamente seguimiento por ANI, el 21/4 se inicia de NPE, en miras de metas, pre-alb 25. El 06/05 se instala GTT, cursa con dolor que requirió evaluación por CX, actualmente en disminución. Dado disociación bun/crea, caída de Hb progresiva sin exteriorización de sangrado, asociado a aumento de débitos por GTT, y secreción purulenta por herida operatoria, se decide realizar imagen de abdomen. TAC AP, examen sin evidencias categóricas de filtración de gastrostomía. Leve ascitis en excavación pelviana. Se decide ajustar medida, por lo que se suspende nutrición parenteral y régimen cero por GTT por íleo y altos débitos. Iniciar con débitos 300cc. Se deja suero glucosado ev. Plan: Evaluar hidratación por GTT según débitos

-Renal/Medio interno: sin creatinina basal, evoluciona con AKI oligúrica en contexto de sepsis con requerimientos de TRR (23/02-14/03), posteriormente recupera función renal. De entonces algunas fluctuaciones en contexto de obstrucción del CUP y otras ante hipovolemia. La semana pasada tuvo aumento de crea hasta 1.13, responde favorablemente a volemicización, hoy en 1.1, sin embargo, mantiene disociación Bun/ Crea, con bun en 77. Hoy al control de exámenes, destaca mantención de hipernatremia, pese a hidratación y volemicización cautelosa, en contexto de mal manejo de volúmenes. Plan: Seguimiento de función renal, eventual hidratación con agua libre por GTT en caso de débitos disminuidos.

-Fisiatría: ev por equipo, sugieren inicio de IRSS para prevención de tr adaptativo secundario a alteración de comunicación. Además, se sugiere ortesis con dispositivo copatador de hombro izquierdo talla L, para evitar lesiones musculares. Se conversa con familiares, pendiente copatador de hombro izquierdo.

-Oftalmología: Hoy evaluado nuevamente, se mantiene gotas indicadas.

Fecha Epicrisis : 20/05/2022 02:50

Página 4 de 5

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 20-05-2022 2:50:11

Página 5 de 5

-Tromboprofilaxis: Sin tromboprofilaxis por antecedente de hematoma con caída de Hb.

02:20

Se constata fallecimiento

se intenta avisar a familiares en multiples ocasiones

el telefono suena , no contestan el telefono y luego se reporta apagado

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Respiratoria Aguda -
Cetoacidosis Diabética -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Se intenta avisar a familiares

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Jhony Gomez Mendoza
Médico Tratante (Staff)